

DSA Parte 2 e Polyhandicap — Schema

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 09

ASD — Diagnosi e analisi funzionale

- **Diagnosi medica** → non guida il lavoro educativo
 - **Analisi funzionale** → osserva come la persona funziona nel suo contesto
 - Difficoltà e disabilità
 - Capacità residue e recuperabilità
 - **Potenzialità di sviluppo** → qui si costruiscono gli obiettivi
-

Aree del PEI (Piano Educativo Individualizzato)

- **Abilità motorie** → base dell'apprendimento; spesso trascurate
 - **Autonomie personali** → dipendono da motricità fine e sviluppo corporeo
 - **Apprendimenti scolastici** → parte del progetto di vita
 - **Abilità sociali** → area più critica
 - *Strumentali* → generare reciprocità (es. linguaggio)
 - *Relazionali* → interpretare emozioni, adattarsi ai contesti (Castaldo et al., 2021)
 - **Comunicazione** → area fondamentale; lavorare sui prerequisiti
-

Abilità vs. Competenze sociali

- **Abilità** → comportamento specifico appreso
- **Competenza** (Keller, 2021) → usare le abilità nel contesto giusto + funzioni metacognitive

- **Ostacoli alle competenze** in ASD:
 - Fattori neurobiologici
 - Comorbidità psichiatriche (ansia, depressione)
 - Mancanza di motivazione (da ripetuti fallimenti)
-

Prerequisiti della comunicazione

Prerequisito	Descrizione breve
Percezione sensoriale	Ascoltare, osservare espressioni e gesti
Interazione sociale	Interesse per l'altro e per il mondo
Imitazione	Difficoltà tipica nell'ASD
Gestualità	Precede il linguaggio verbale
Attenzione condivisa	Focalizzarsi sullo stesso oggetto con un'altra persona
Intento comunicativo	Voler comunicare — va sviluppato
Sviluppo cognitivo	Pattern, memoria, associazione di idee

- **CAA** (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) → quando il verbale non è raggiungibile
 - **PECS** → Picture Exchange Communication System (carte-immagine)
 - **7 funzioni linguistiche** (Halliday, 1975-1980):
 - Strumentale · Regolatoria · Interazionale · Personale · Euritmica · Referenziale · Immaginativa
-

Caratteristiche degli interventi ASD

- **Training quotidiani e ripetuti** → da tutti (scuola, casa, istituto)
- **Metodologia strutturata** → no improvvisazione
- **Rete allargata** → genitori parte centrale
- **Prima abbassare l'ansia** → struttura + prevedibilità → poi training

- **Comportamenti problema** → funzione comunicativa → sostituire, non sopprimere
 - Strumento: **valutazione funzionale**
 - **Motivazione** → punto di partenza; usare gli interessi della persona
-

Principi guida (11 totali)

1. Diagnosi precoce
 2. Obiettivi individualizzati (comunicazione, socializzazione, comportamento adattivo)
 3. Collaborazione genitori-professionisti + PEI periodico
 4. Insegnamento strutturato, massiccio, da parte di tutti
 5. Adattamento dell'ambiente
 6. Sviluppo delle potenzialità
 7. Diversi metodi e approcci
 8. Servizi coordinati per tutto il ciclo di vita
 9. Conoscenza aggiornata dell'autismo
 10. Conoscenza delle risorse ed esperienze esistenti
 11. Formazione e scelta del personale
-

Approcci e metodi

Approccio	Autore / Anno	Principio chiave
ABA	Skinner (1904-1990)	Rinforzo comportamento in setting 1:1
Approcci naturalistici	Koegel et al. (1979)	Iniziativa del bambino in contesti spontanei
CBT	Ellis e Beck, anni '60	Pensieri + emozioni + comportamenti
Training abilitativi	Moderato	Abilità specifiche da bilancio funzionale

Approccio	Autore / Anno	Principio chiave
CAA / PECS	—	Comunicazione simbolica alternativa
TEACCH	Schopler (1972)	Struttura visiva + adattamento ambientale
Approcci evolutivi	—	Reciprocità, imitazione, attenzione condivisa
ESDM (Denver)	Rogers e Dawson, anni 2000	Parent training + ABA + sviluppo; da 12 mesi

Famiglie nell'ASD

- **Parent training** → parte integrante dell'intervento
- Relazione su fiducia: rispetto, coerenza, trasparenza, competenza
- No pietà / No giudizio / No esclusione

Rischi professionali: terapie di moda, improvvisazione, visione breve, assistenzialismo, esclusione famiglia

Risorsa Ticino: Fondazione ARES → fondazioneares.com

Polyhandicap — Definizione

- **Deficit grave, ad espressioni multiple**
 - Deficit fisico importante
 - Deficit intellettuale severo o profondo
- **Causa** → danno cerebrale grave, incurabile, precoce (prima dei 3 anni)
- **Effetto** → restrizione estrema di autonomia, percezione, espressione, relazione
- Evolve nel tempo (non statico)

Le 5 dimensioni AAIDD nel polyhandicap

Dimensione	Caratteristica
Funzionamento intellettuale	Profondo; ≈ bebè 6 mesi; periodo senso-motorio Piaget (stadi 1-4)
Funzionamento adattivo	Dipendenza totale (cure, alimentazione); comunicazione solo non verbale
Salute	Polipatologie gravi evolutive; epilessia frequente; mortalità elevata
Interazione/partecipazione	Interazioni inesistenti o povere; dipendenza totale
Contesto	Équipe pluridisciplinare; esigenze etiche massime

- **Sostegni** → livello maggiore e intensivo (AAMR, 2002)
-

Salute e dolore nel polyhandicap

- **Deficit motorio** → problemi posturali → respiratori → ortopedici (effetti a cascata)
 - **Dolore in 4 forme:**
 - Dolori comuni (mal di denti, influenza)
 - Dolori da polipatologia
 - Salute mentale
 - Dolori da cure quotidiane
 - **Cambiamenti di comportamento** → possibile segnale di dolore fisico non comunicato
 - **Epilessia** → dopo crisi, possibile sonno di 24h → adeguarsi
-

Comunicazione nel polyhandicap

- **Comprensione** precede sempre la **produzione**
 - Non produrre ≠ non capire → errore da non fare mai
 - Canale principale: comunicazione non verbale (sguardo, gesti minimi)
 - **Causalità elementare** (campanelle, oggetti) → base per agire sull'ambiente
→ base per comunicare
-

Famiglie nel polyhandicap

- Sostegno in tutti i momenti chiave:
 - Annuncio diagnosi · Informazioni · Accesso servizi
 - Organizzazione familiare · Transizione vita adulta
 - **Mai soli** con questo tipo di utenza → équipe sempre
 - **Dimensione etica** → persona non verbale, non può segnalare abusi → supervisione fondamentale
-

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Villa e Vivanti	Citazione sull'esperienza del mondo con ASD	2007
Castaldo et al.	Abilità sociali strumentali e relazionali	2021
Keller	Definizione competenze sociali e metacognizione	2021
Halliday	7 funzioni linguistiche	1975-1980
Skinner	ABA e condizionamento operante	1904-1990
Koegel et al.	Approcci naturalistici	1979
Ellis e Beck	CBT (Terapia Cognitivo-Comportamentale)	anni '60
Schopler	TEACCH	1972

Chi	Cosa	Quando
Rogers e Dawson	ESDM (Modello Denver)	anni 2000
Moderato	Training abilitativi	—
AAMR / AAIDD	Classificazione sostegni e deficit intellettivo	2002

Parole chiave

ASD · analisi funzionale · PEI · attenzione condivisa · CAA · PECS · ABA · TEACCH · ESDM · parent training · comportamento problema · valutazione funzionale · training · polyhandicap · AAIDD · deficit intellettivo profondo · periodo senso-motorio · epilessia · causalità elementare · Fondazione ARES